PROTOCOLLO 48

Allungamento del temporale

Ridurre la tensione del temporale e la cefalea associata

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Mialgia, cefalea attribuita a DTM	5 minuti	Ogni seduta

Indicazioni

- ✓ Cefalea temporale
- ✓ Tensione del temporale alla palpazione
- ✓ Apertura limitata

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo



Apertura

Il paziente apre fino al limite confortevole.



Fissazione

Le dita fissano la fascia temporale verso l'alto.



Scivolamento

Il paziente chiude lentamente mentre mantieni la fissazione.



Ripeti

Cambia zona: anteriore, media, posteriore.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Ripetizioni	3 per zona
Velocità	lenta
Intensità	confortevole

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Combina rilascio e movimento attivo
- ✓ Lavora tutte le porzioni
- ✓ Osserva la riduzione della cefalea

Errori da evitare

- ! Pressione eccessiva sull'osso
- ! Movimenti rapidi
- ! Ignorare il dolore riferito ai denti

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Rilascio attivo	Dita sulla tempia mentre si chiude lentamente la bocca	5 per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il rilascio con movimento attivo è utile nei pazienti con cefalea di tipo tensivo associata.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.